



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN HASIL SURVEYBUDAYA KESELAMATAN
PASIE
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

KATA PENGANTARii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan Umum 1

1.1 Tujuan Khusus..... 1

BAB II METODE SURVEY 2

2.2 Bahan dan Metode..... 2

BAB III HASIL KEGIATAN 3

3.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 3

3.2 Gambaran Karakteristik Responden 3

3.3 Gambaran Survey Budaya Keselamatan Pasien 5

BAB V PENUTUP..... 19

5.1 Kesimpulan..... 19

5.2 Saran..... 19

KATA PENGANTAR

Keselamatan Pasien/KP (Patient Safety) merupakan issue Global dan Nasional bagi rumah sakit dan merupakan komponen penting dari mutu pelayanan kesehatan, serta merupakan prinsip dasar dalam pelayanan pasien dan komponen kritis dalam manajemen mutu (WHO, 2004). Perhatian dan Fokus terhadap Keselamatan Pasien ini didorong oleh masih tingginya angka kejadian Tak Diinginkan (KTD) atau *Adverse Event* (AE) di rumah sakit baik secara global maupun nasional.

Sebagai upaya memecahkan masalah tersebut dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih aman diperlukan suatu perubahan budaya dalam pelayanan kesehatan maka dilakukannya survey budaya keselamatan pasien uni untuk mengetahui gambaran budaya keselamatan pasien yang dilakuka oleh staf Rumah Sakit Prima Husada Malang .

Assesmen dalam survey ini menggambarkan tingkat budaya keselamatan pasien dalam satu waktu tertentu saja sehingga membutuhkan pengulangan assesmen secara berkala untuk menilai perkembangannya. Dengan adanya survey budaya keselamatan pasien ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijakan mengenai kepatuhan staf dalam menjalankan budaya keselamatan pasien.

Malang, 13 Desember 2025

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit akan memberikan dampak yang merugikan bagi pihak Rumah Sakit, Staff, dan pasien sebagai penerima pelayanan. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit. Untuk meminimalisir terjadinya Kejadian yang tidak diharapkan terkait dengan aspek keselamatan pasien, maka manajemen Rumah Sakit perlu menciptakan budaya keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien merupakan pondasi utama dalam menuju keselamatan pasien, dengan adanya perilaku membudaya keselamatan pasien secara signifikan akuntabilitas Rumah Sakit di mata pasien dan masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya kinerja Rumah Sakitpun meningkat.

Pada umumnya seluruh Rumah Sakit sudah mengaplikasikan system keselamatan yang baik, tetapi pada kenyataannya insiden terkait pasien tetap terjadi namun insiden dapat ditekan sekecil-kecilnya. Namun, faktanya system tidak dapat berjalan secara optimal jika kompetensi dan nilai-nilai budaya yang ada tidak mendukung. Penerapan budaya keselamatan pasien akan mendatangkan keuntungan bagi pasien dan pihak pelayanan kesehatan. Dengan adanya penerapan budaya keselamatan kesalahan yang terjadi akan terdeteksi kesalahan yang terjadi atau yang akan terjadi. Selain itu, penerapan budaya keselamatan pasien akan meningkatkan kesadaran staff untuk mencegah *error*, meningkatkan budaya lapor jika terjadi kesalahan di unit kerja dan menengurangi pengeluaran finansial yang diakibatkan oleh kejadian keselamatan pasien (Carthey & Clarke dalam Beginta, 2021)

Budaya keselamatan pasien menurut *Association Health Care and Research Quality* (AHRQ) dapat diukur dari segi perspektif staff Rumah Sakit yang terdiri dari 12 dimensi yaitu : harapan dan tindakan manajer mempromosikan keselamatan pasien, *organizational learning* – perbaikan berkelanjutan, kerjasama dalam unit, komunikasi terbuka, umpan balik dan komunikasi mengenai kesalahan, respon *non-punitive* terhadap kesalahan, *staffing*, dukungan manajemen terhadap upaya keselamatan pasien, kerjasama antar unit di Rumah Sakit terkait keselamatan pasien, dan frekuensi pelaporan kejadian (AHRQ, 2004)

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang tercantum di Keputusan Menteri Kesehatan No 129/Menkes/SK/II/2008, menjelaskan bahwa di Rumah Sakit tidak boleh ada kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Sedangkan di RS Prima Husada Malang berdasarkan data insiden keselamatan pasien pada bulan Januari sampai september tahun 2024 masih terdapat insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit yaitu insiden yang menyebabkan kematian atau sentinel, KNC maupun KTD. Melihat masih banyaknya masalah keselamatan pasien di RS Prima Husada Malang dan pentingnya penerapan budaya keselamatan pasien, maka dilakukan pengukuran atau survei budaya keselamatan pasien di RS Prima Husada Malang pada seluruh staff di Rumah sakit.

1.2 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambar budaya keselamatan pasien pada staf RS Prima Husada Malang pada tahun 2025

1.3 Tujuan Khusus

- 1.3.1.** Mengukur budaya keselamatan pasien di RS Prima Husada Malang .
- 1.3.2.** Mengetahui gambaran budaya keselamatan pasien di setiap unit RS Prima Husada Malang .
- 1.3.3.** Melaksanakan program pencegahan terkait Insiden Keselamatan Pasien di RS Prima Husada Malang .
- 1.3.4.** Mengevaluasi efektivitas intervensi keselamatan pasien dari waktu ke waktu.

BAB II METODE SURVEY

2.1. Bahan dan Metode

Survey ini dilaksanakan di Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Desember Tahun 2025. Survey ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam survey ini dengan menggunakan teknik *proportional stratified random sampling*. Proses pengambilan subjek di mana akan diambil responden di area atau lapisan yang berbeda dari berbagai unit Rumah Sakit secara acak dan sesuai proporsi. Teknik ini merupakan cara pengambilan sampel populasi yang memiliki unsur tidak homogen dan berstrata secara proporsional dari setiap elemen sampel, dan pengambilan sampel ini juga dilakukan secara random atau acak.

Alat pengumpulan data dalam survey ini adalah kuesioner Budaya Keselamatan Pasien yang di adopsi dari Kuesioner *Hospital Survey on Patient Safety Culture* dipublikasikan oleh *The Agency for Health care Research and Quality* tahun 2019. Instrumen kuesioner ini terdiri dari 41 pernyataan yang mencakup dimensi budaya keselamatan pasien yang di desain untuk semua staff. data survey ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif menggunakan computer dan disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III HASIL KEGIATAN

3.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang

Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai pelayanan kesehatan memiliki peran aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat pada umumnya dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Hal tersebut tercermin dalam visi, misi dan motto Rumah Sakit Prima Husada Sebagai Berikut:

1. Visi

Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2. Misi

- Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
- Mengutamakan kepuasan pasien
- Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

3. Motto

Sahabat menuju sehat

Rumah sakit prima husada malang memiliki prinsip khusus untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan landasan 7 Nilai budi utama, yakni:

- Jujur
- Tanggung jawab
- Visioner
- Disiplin
- Kerjasama
- Adil
- Peduli

3.2 Gambaran Karakteristik Responden

Tabel 3.1 Gambaran Karakteristik Responden

No	Kategori Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	17-25	26	10,3%
2	26-35	182	72,5%
3	36-45	29	11,5%
4	46-55	11	4,4%
5	56-65	3	1,2%
Jumlah		TOTAL	251

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa mayoritas usia responden berada pada kategori usia 26-35% yakni dengan persentase sebesar 72,5%. Sedangkan pada kategori usia 56-65 tahun memiliki jumlah paling sedikit dengan persentase 1,2%.

Tabel 3.2 Gambaran Karakteristik Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – Laki	75	29,9%
2	Perempuan	176	70,1%
Jumlah		251	100%

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui mayoritas responden yang mengisi survey budaya

keselamatan pasien yakni staff perempuan dengan presentase 70,1%. Sementara responden berjenis kelamin laki-laki sejumlah 75 orang (29,9%).

Tabel 3.3 Gambaran Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA/ SMK	29	11,5%
2	D3/D4	103	41,1%
3	S1/S2/S3	104	41,4%
4	YANG LAIN	15	6%
Jumlah		251	100%

Berdasarkan data tingkat pendidikan responden, sebagian besar responden memiliki pendidikan tinggi. Responden dengan pendidikan S1/S2/S3 merupakan kelompok terbanyak yaitu 104 orang (41,4%), diikuti oleh responden dengan pendidikan D3/D4 sebanyak 103 orang (41,1%). Sementara itu, responden dengan pendidikan SMA/SMK berjumlah 29 orang (11,5%), dan kategori lainnya sebanyak 15 orang (6%). Dari total 251 responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan D3/D4 hingga S1/S2/S3 sebesar 82,5%, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi.

Tabel 3.4 Gambaran Lokasi Kerja Responden

No	Lokasi Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pelayanan	218	86,8%
2	Non Pelayanan	33	13,2 %
Jumlah		251	100%

Berdasarkan data lokasi kerja responden, sebagian besar responden bekerja di unit pelayanan yaitu sebanyak 218 orang (86,8%). Sementara itu, responden yang bekerja di unit non pelayanan berjumlah 33 orang (13,2%). Dari total 251 responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari area pelayanan, sehingga hasil penelitian lebih banyak merepresentasikan kondisi dan persepsi tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan kepada pasien.

Tabel 3.5 Gambaran Ketersediaan Pelatihan Patient Safety

No	Ketersediaan Pelatihan Patient Safety	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	215	85,7%
2	Tidak	36	14,3%
Jumlah		251	100%

Berdasarkan data ketersediaan pelatihan patient safety, sebagian besar responden menyatakan bahwa pelatihan patient safety tersedia di tempat kerja mereka, yaitu sebanyak 215 orang (85,7%). Sementara itu, 36 orang (14,3%) menyatakan bahwa pelatihan patient safety tidak tersedia. Dari total 251 responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah memiliki akses terhadap pelatihan patient safety, yang menunjukkan adanya upaya organisasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi staf terkait keselamatan pasien.

Tabel 3.6 Gambaran Partisipasi Staff dalam Pelatihan Patient Safety

No	Partisipasi Staff dalam Pelatihan Patient Safety	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	204	81,3%
2	Tidak	47	18,7%
Jumlah		251	100%

Berdasarkan data partisipasi staf dalam pelatihan patient safety, sebagian besar responden menyatakan pernah mengikuti pelatihan patient safety, yaitu sebanyak 204 orang (81,3%). Sementara itu, 47 orang (18,7%) menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan tersebut. Dari total 251 responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas staf telah berpartisipasi dalam pelatihan patient safety, yang menunjukkan adanya keterlibatan yang cukup baik dalam upaya peningkatan pengetahuan dan penerapan budaya keselamatan pasien di lingkungan kerja.

Tabel 3.7 Gambaran Persepsi Staff tentang Sistem Pelaporan IKP

No	Persepsi Staff tentang Sistem Pelaporan IKP	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	65	26%
2	Kurang	186	74%

Jumlah	251	100%
--------	-----	------

Berdasarkan data persepsi staf tentang sistem pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), sebagian besar responden menilai bahwa sistem pelaporan IKP masih kurang, yaitu sebanyak 186 orang (74%). Sementara itu, 65 orang (26%) menilai sistem pelaporan IKP sudah baik. Dari total 251 responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas staf memiliki persepsi yang kurang baik terhadap sistem pelaporan IKP, yang mengindikasikan masih terdapat aspek-aspek dalam sistem pelaporan yang perlu diperbaiki agar lebih efektif, mudah digunakan, dan mampu mendorong pelaporan insiden secara optimal.

Tabel 3.8 Gambaran Persepsi staff tentang Sifat Pelaporan Insiden

No	Sifat Pelaporan Insiden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	217	86,4%
2	Tidak	34	13,6%
Jumlah		251	100%

Berdasarkan data mengenai sifat pelaporan insiden, sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaporan insiden telah memiliki sifat yang sesuai, yaitu sebanyak 217 orang (86,4%). Sementara itu, 34 orang (13,6%) menyatakan sebaliknya. Dari total 251 responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menilai bahwa pelaporan insiden telah dilaksanakan sesuai prinsip yang diharapkan, sehingga dapat mendukung pelaporan insiden secara lebih terbuka dan mendorong upaya peningkatan keselamatan pasien di lingkungan kerja.

Tabel 3.9 Gambaran Pembelajaran Staff dari IKP yang sudah Terjadi

No	Pembelajaran Staff dari IKP yang sudah Terjadi	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	200	80%
2	Tidak	51	20%
Jumlah		251	100%

Berdasarkan data pembelajaran staf dari Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang telah terjadi, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka memperoleh pembelajaran dari IKP, yaitu sebanyak 200 orang (80%). Sementara itu, 51 orang (20%) menyatakan tidak memperoleh pembelajaran dari IKP yang terjadi. Dari total 251 responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas staf telah memanfaatkan kejadian insiden sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah terulangnya insiden serupa, meskipun masih terdapat sebagian responden yang belum merasakan adanya proses pembelajaran tersebut.

Tabel 3.10 Gambaran Kepatuhan Staff dalam Melaporkan IKP ke Otoritas Lebih Tinggi

No	Kepatuhan Staff dalam Melaporkan IKP ke Otoritas Lebih Tinggi	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	200	80%
2	Tidak	51	20%
Jumlah		251	100%

Berdasarkan data kepatuhan staf dalam melaporkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) kepada otoritas yang lebih tinggi, sebagian besar responden menyatakan patuh dalam melaporkan IKP, yaitu sebanyak 200 orang (80%). Sementara itu, 51 orang (20%) menyatakan tidak patuh dalam melaporkan IKP kepada otoritas yang lebih tinggi. Dari total 251 responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas staf telah menunjukkan kepatuhan dalam pelaporan IKP sesuai jalur pelaporan yang berlaku. Namun, masih terdapat sebagian staf yang belum melakukan pelaporan secara konsisten, sehingga diperlukan upaya peningkatan kepatuhan untuk mendukung sistem pelaporan insiden yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.11 Gambaran Posisi Responden di Rumah Sakit

No	Posisi	Frekuensi
1	Dokter (Umum, gigi, spesialis)	14
2	Perawat Vokasi	65
3	Perawat profesi	88
4	Bidan	8
5	Farmasi / Apoteker	10

6	Analisis Kesehatan	4
7	Driver	2
8	Cleaning Service	15
9	IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)	2
10	Security	3
15	CSSD/Laundry	4
16	Admin unit, sekretaris, resepsionis, staf kantor	29
19	Direktur, Wakil direktur, kepala bidang, manajer	1
20.	Parkir	6
Jumlah		251

Jika melihat tenaga medis dan non medis yang mengisi kuesioner ini, perawat profesi merupakan responden terbanyak yaitu 88 orang. Tenaga professional tersebut yang melaksanakan tugas di unit rawat jalan dan rawat inap dan merupakan profesional asuhan yang berinteraksi langsung dengan pasien, sehingga harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan tindakan maupun pemeriksaan terhadap pasien, berusaha untuk meminimalisir kesalahan, menghindari komplain dan lebih mengutamakan keselamatan pasien.

3.3 Gambaran Dimensi Budaya Keselamatan Pasien

Pada bagian ini disajikan gambaran secara kuantitatif 10 dimensi budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Suatu budaya keselamatan pasien dikatakan budaya baik apabila respon positif sebesar $\geq 75\%$ atau tinggi, budaya sedang apabila respon positif sebesar 50%-75%, dikatakan budaya rendah apabila respon positif $\leq 50\%$. Respon positif adalah jawaban berupa setuju/sering dan sangat setuju / selalu pada pernyataan positif, dan jawaban negative tidak setuju / jarang dan sangat tidak setuju/tidak pernah pada pernyataan negative.

1. Dimensi Umpan Balik & Komunikasi Tentang Kesalahan

Tabel 3.12 Dimensi Umpan Balik & Komunikasi Tentang Kesalahan

No	Tiga hal yang mengukur komunikasi tentang kesalahan	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item C1- Kata Positif				
	Kami diberitahu tentang kesalahan yang terjadi di unit ini	246	5	251	98.01%
2	Item C2- Kata Positif				
	Ketika kesalahan terjadi di unit ini, kami membahas bagaimana cara untuk mencegah terulang kembali	246	5	251	98.01%
3	Item C3- Kata Positif				
	Di unit ini, kami diberitahu tentang perubahan yang dibuat berdasarkan laporan insiden	246	5	251	98.01%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					98.01%

Dimensi ini memperoleh nilai 98,01% (kategori tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa staf telah memiliki kesadaran dan kemauan yang sangat baik dalam mengkomunikasikan kesalahan yang terjadi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan keselamatan pasien.

2. Dimensi Keterbukaan Komunikasi

Tabel 3.13 Dimensi Keterbukaan Komunikasi

No	Empat hal yang mengukur keterbukaan komunikasi	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sebagian besar atau selalu	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon tidak pernah atau jarang	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Responpositif untuk item
1	Item C4- Kata Positif				
	Di unit ini, anda akan berbicara jika mereka melihat sesuatu yang dapat mempengaruhi perawatan pasien secara negatif	241	10	251	96.02%
2	Item C5- Kata Positif				
	Saat staf di unit ini melihat seseorang dengan kewenangan yang lebih melakukan sesuatu yang tidak aman bagi pasien, maka staf berani mengingatkan	248	3	251	98.80%
3	Item C6- Kata Positif				
	Ketika staf di unit ini mengingatkan, mereka yang memiliki kewenangan lebih terbuka terhadap masalah keselamatan pasien mereka	225	26	251	89.64%
4	Item C7- Kata Negatif				
	Di unit ini, karyawan takut mengajukan pertanyaan ketika ada yang tidak benar terjadi	63	188	251	74.90%
Persentase respon positif rata-rata di 4 item					89,84%

Pada dimensi keterbukaan komunikasi dihasilkan rata-rata respon positif petugas sebanyak 89,84% yang artinya dimensi keterbukaan komunikasi dalam kategori tinggi. Keterbukaan komunikasi antara staff dan pimpinan merupakan aspek yang penting dan harus dijaga. Dimana komunikasi yang baik dapat menghilangkan kecurigaan dan prasangka negatif. Tak hanya itu keterbukaan komunikasi akan meningkatkan rasa saling mengerti sehingga pesan yang tersampaikan mudah dipahami. Selain itu, informasi yang didapatkan yakni secara faktual dan akurat yang dapat mengurangi pencegahan kasus keselamatan pasien. Sistem pelaporan keselamatan pasien dilakukan dalam bentuk keterbukaan komunikasi yang merupakan bentuk informasi kepada manajemen terkait kasus yang ada sehingga insiden keselamatan pasien tidakakan terjadi lagi.

3. Dimensi serah terima & pertukaran informasi

Tabel 3.14 Dimensi Serah Terima & Pertukaran Informasi

No	Tiga hal yang mengukur serah terima dan pertukaran informasi	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item F4- Kata Negatif				
	Ketika transfer pasien dari satu unit ke unit yang lain, informasi penting sering tidak tersampaikan	73	178	251	70.92%
2	Item F5- Kata Negatif				
	Selama perubahan shift, informasi perawatan pasien yang penting sering tidak tersampaikan	44	207	251	82.47%
3	Item F6- Kata Positif				
	Selama perubahan shift, ada waktu yang cukup adekuat untuk bertukar semua informasi penting perawatan pasien	232	19	251	92.43%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					81,94%

Dimensi serah terima dan pertukaran informasi memperoleh nilai 81,94% (kategori tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa proses handover antar petugas telah berjalan dengan baik, meskipun tetap diperlukan konsistensi dalam penerapan komunikasi efektif untuk mencegah kesalahan akibat informasi yang tidak lengkap.

4. Dimensi Dukungan manajemen Rumah sakit untuk keselamatan pasien

Tabel 3.15 Dimensi Dukungan Manajemen Rumah Sakit untuk Keselamatan Pasien

No	Tiga hal yang mengukur dukungan manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item F1- Kata Positif				
	Tindakan manajemen RS menunjukkan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama	248	3	251	98.80%
2	Item F2- Kata Positif				
	Manajemen RS menyediakan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan keselamatan pasien	230	21	251	91.63%
3	Item F3- Kata Negatif				
	Manajemen RS tampaknya tertarik pada keselamatan pasien hanya setelah terjadi insiden	155	96	251	38.25%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					76,23%

Berdasarkan hasil survey, dukungan manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang terhadap upaya keselamatan pasien mendapat respon positif. Pada dimensi dukungan manajemen rumah sakit terhadap keselamatan pasien sebesar 76,23% termasuk dalam kategori sedang. Bentuk dukungan manajemen adalah mengadakan sarana dan kelengkapan untuk keselamatan pasien, adanya kebijakan manajemen terkait keselamatan pasien, memberikan motivasi staf ketika ada insiden keselamatanpasien baik itu KPC, KNC, ataupun KTD, serta mengadakan kegiatan pelatihan. Dukungan manajemen tidak akan berlangsung apabila tidak kerja sama antar pegawai.

5. Dimensi Pembelajaran Organisasi

Tabel 3.16 Dimensi Pembelajaran Organisasi

No	Tiga hal yang mengukur pembelajaran organisasi-peningkatan berkelanjutan	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item A4- Kata Positif				
	Unit ini secara berkala meninjau proses kerja untuk menentukan apakah perlu perubahan meningkatkan keselamatan pasien	240	11	251	95.62%
2	Item A12- Kata Positif				
	Di unit ini, perubahan untuk meningkatkan keselamatan pasiendi evaluasi untuk melihat seberapa baik mereka bekerja	238	13	251	94.82%
3	Item A14- Kata Negatif				
	Unit ini membiarkan masalah keselamatan pasien yang lama terjadi lagi	41	210	251	83.67%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					91,37%

Berdasarkan hasil survey pada dimensi pembelajaran organisasi respon positif didapatkan nilai 91,37% dengan kategori budaya tinggi. Unit-unit di Rumah Sakit Prima Husada Malang melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan ketika ada insiden keselamatan pasien yang berupa staff di unit melakukan budaya belajar dari insiden yang telah terjadi dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut agar insiden tidak terulang Kembali.

6. Dimensi Melaporkan Peristiwa Keselamatan Pasien

Tabel 3.17 Dimensi Melaporkan Peristiwa Keselamatan Pasien

No	Dua hal yang mengukur melaporkan kejadian keselamatan pasien	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sebagian besar atau selalu	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon tidak pernah atau jarang	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item D1- Kata Positif				
	Ketika insiden kesalahan diketahui dan diperbaiki sebelum mengenai/menimpa pasien, seberapa sering ini dilaporkan? (KNC)?	190	61	251	75.70%
2	Item D2- Kata Positif				
	Ketika insiden/kesalahan sudah mengenai/menimpa pasien tetapi tidak mencederai pasien, seberapa sering ini dilaporkan? (KTC)	172	79	251	68.53%
Persentase respon positif rata-rata di 2 item					72,11%

Berdasarkan hasil survey pada dimensi melaporkan peristiwa keselamatan pasien yaitu 72,11% dalam kategori sedang. Ketika ada insiden Keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang pada alurnya seharusnya dilaporkan ke atasan secara langsung untuk penanganan dan ke Komite PMKP untuk dilakukan grading matriks, dan diperlukan investigasi lanjutan untuk mendapatkan tindak lanjut dari insiden keselamatan pasien. Budaya lapor yang sedang ini diakibatkan kurangnya pemahaman petugas dalam melaporkan IKP, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelaporan insiden, ketakutan untuk melaporkan dan tingginya beban kerja.

Upaya yang dilakukan rumah sakit untuk budaya lapor dapat memperlakukan adil terhadap staf, tidak menyalahkan secara individu tetapi organisasi lebih fokus terhadap sistem yang berjalan akan meningkatkan budaya pelaporan. Pelaporan insiden menjadi titik awal dalam program keselamatan pasien. Melalui mekanisme pelaporan yang baik akan mampu mengidentifikasi permasalahan yang kemudian dapat dirumuskan solusi perbaikannya.

7. Dimensi Respon Terhadap Kesalahan

Tabel 3.18 Dimensi Respon Terhadap Kesalahan

No	Empat hal yang mengukur respon terhadap error	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item A6- Kata Negatif				
	Di unit ini, staf merasa bahwa kesalahan mereka digunakan untuk menghukum mereka	74	177	251	70.52%
2	Item A7- Kata Positif				
	Ketika insiden dilaporkan di unit ini, sepertinya yang dicatat orangnya, bukan masalahnya	80	171	251	31.87%
3	Item A10- Kata Positif				
	Ketika staf membuat kesalahan, di unit ini focus pada pembelajaran daripada menyalahkan individu	223	28	251	88.84%
4	Item A13- Kata Negatif				
	Di unit ini, kurang mendapat dukungan untuk staf yang terlibat dalam insiden keselamatan pasien	71	180	251	71.71%
Persentase respon positif rata-rata di 4 item					64,14%

Ketika terjadi insiden, selayaknya tidak berfokus untuk mencari kesalahan individu tetapi lebih mempelajari secara sistem yang mengakibatkan terjadinya kesalahan. Budaya tidak menyalahkan kepada staf perlu dikembangkan dalam menumbuhkan budaya keselamatan pasien. Biasanya staf baru akan membuat laporan kejadian jikayakin bahwa laporan tersebut tidak akan mendapatkan hukuman atas kesalahan yangterjadi.

Lingkungan terbuka dan adil akan membantu pelaporan yang dapat menjadi pelajaran dalam keselamatan pasien. Berdasarkan hasil survey didapatkan hasil sebesar 64,14% termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa staf berani melaporkan insiden yang terjadi dan tidak ada rasa khawatir disalahkan.

8. Dimensi Kepegawaian & Kecepatan Kerja

Tabel 3.19 Dimensi Kepegawaian & Kecepatan Kerja

No	Empat hal yang mengukur kepegawaian dan kecepatan kerja	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item A2- Kata Positif				
	Di unit ini, kami memiliki staf yang cukup untuk menangani beban kerja	149	102	251	59.36%
2	Item A3- Kata Negatif				
	Staf di unit ini bekerja lebih lama untuk memberikan perawatan pasien yang terbaik	56	195	251	77.69%
3	Item A5- Kata Negatif				
	Unit ini terlalu mengandalkan pada staf sementara (kontrak/honoror)	59	192	251	76.49%
4	Item A11- Kata Negatif				
	Di unit ini bekerja tergesa-gesa sehingga berdampak negatif terhadap keselamatan pasien	49	202	251	80.48%
Persentase respon positif rata-rata di 4 item					78,22%

Pada dimensi kepegawaian dan kecepatan kerja dalam survey ini respon positif yang didapatkan sebesar 78,22%, termasuk dalam kategori budaya sedang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sumber daya manusia di rumah sakit sebagai tenaga profesional pelaksana langsung pelayanan belum memenuhi kecukupan baik kuantitas dan kualitas. Namun pelayanan tetap harus dilaksanakan secara optimal. Aspek kualitas dilihat dari pendidikan dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap profesional. Kompetensi setiap profesional di rumah sakit sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) yang ditetapkan melalui Surat Penugasan Klinis (SPK) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Prima Husada Malang, dimana sebelumnya profesional pemberi asuhan telah memiliki STR dan SIP. Langkah ini juga harus terintegrasi dengan perencanaan SDM rumah sakit khususnya kompetensi Yankes dalam memenuhi standar tersebut.

9. Dimensi Supervisor / Manajer / Pimpinan Klinis untuk Keselamatan Pasien

Tabel 3.20 Dimensi Supervisor / Manajer / Pimpinan Klinis untuk Keselamatan Pasien

No	Tiga hal yang mengukur supervisor, manajer, atau pemimpin klinis dukungan untuk keselamatan pasien	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item B1- Kata Positif				
	Atasan, manajer, atau pemimpin klinis saya dengan serius mempertimbangkan saran staf untuk meningkatkan keselamatan pasien	242	9	251	96.41%
2	Item B2- Kata Negatif				
	Atasan, manajer, atau pemimpin klinis saya ingin agar kami bekerja lebih cepat di saat sibuk, walaupun harus mengambil jalan pintas	163	88	251	35.06%
3	Item B3- Kata Positif				
	Atasan, manajer, atau pemimpin klinis saya melakukan tindakan untuk mengatasi masalah keselamatan pasien yang menjadi perhatian mereka	240	11	251	95.62%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					75,70%

Pada dimensi ini respon positif yang didapatkan sebesar 75,70% yang dapat dikategorikan dalam budaya tinggi. Manajer dalam survey ini para kepala bagian, kepala ruangan, kepala unit yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan anggota dalam meyakinkan pelayanan yang aman bagi pasien. Hal tersebut dapat disebabkan para manajer sebagai lini pertama memiliki peran kritis dalam mendukung budaya keselamatan pasien dengan kepemimpinan efektif dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi keselamatan pasien.

Berdasarkan hasil survey, manajer di Rumah Sakit Prima Husada Malang telah memberikan dukungannya terhadap keselamatan pasien dibuktikan dengan beberapapoin dalam kuesioner yang mendapat respon positif yang tinggi diantaranya manajer dapat mendengar dan mepertimbangkan saran dari bawahannya untuk meningkatkan keselamatan pasien. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari kepemimpinan efektif dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi keselamatan pasien

10. Dimensi Kerja Tim

Tabel 3.21 Dimensi Supervisor / Manajer / Pimpinan Klinis untuk Keselamatan Pasien

No	Tiga hal yang mengukur kerjasama tim	Untuk item dengan kata-kata positif Respon sangat setuju atau setuju	Untuk item dengan kata-kata negatif Respon sangat tidak setuju atau tidak setuju	Total Respon (Tidak termasuk kosong dan tidak berlaku/tidak tahu)	Persen Respon positif untuk item
1	Item A1- Kata Positif				
	Di unit ini, kami bekerja bersama sebagai tim yang efektif	244	7	251	97.21%
2	Item A8- Kata Positif				
	Jika waktu sibuk (banyak pasien) staf di unit ini saling membantu	238	13	251	94.82%
3	Item A9- Kata Negatif				
	Mereka yang bekerja di unit ini ada masalah terkait, perilaku tidak sopan	52	199	251	79.28%
Persentase respon positif rata-rata di 3 item					90,44%

Pada dimensi kerja tim respon positif 90,44%, yang menggambarkan bahwa dimensi kerja tim dapat dikategorikan budaya keselamatan pasien tinggi. Hal ini disebabkan karena kerja sama tim yang efektif, koordinasi staff di unit saling membantu dan menjaga adab dalam bertingkah laku. Menurut Thompson dalam Setiowati (2010) mendefinisikan tim sebagai sekelompok orang saling terkait terhadap informasi, sumber daya, keterampilan, dan berusaha mencapai tujuan bersama. Kinerja kerja sama tim yang terganggu juga merupakan salah satu penyebab insiden keselamatan pasien yang merupakan kombinasi dari kegagalan sistem.

3.4. Tabel Dimensi Survey Budaya Keselamatan Pasien

Tabel 3.22 Dimensi Survey Budaya Keselamatan Pasien

No	Dimensi	Jumlah	
1	Komunikasi tentang kesalahan	98.01%	Tinggi
2	Keterbukaan Komunikasi	89.84%	Tinggi
3	Serah terima dan pertukaran informasi	81.92%	Tinggi
4	Dukungan Manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien	76.23%	Sedang
5	Pembelajaran Organisasi-Peningkatan berkelanjutan	91.35%	Tinggi
6	Pelaporan kejadian keselamatan pasien	72.11%	Sedang
7	Respon terhadap error	64.14%	sedang
8	Kepegawaian dan kecepatan kerja	78.22%	Sedang
9	Dukungan Supervisor, Manajer, atau Pemimpin Klinis untuk Keselamatan Pasien	75.70%	Sedang
10	Kerjasama Tim	90.44%	Tinggi
Rata - Rata		81.80%	

Berdasarkan hasil Survei Budaya Keselamatan Pasien yang telah dilakukan, diperoleh gambaran tingkat budaya keselamatan pasien pada sepuluh dimensi penilaian dengan capaian rata-rata keseluruhan sebesar 81,80%, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum budaya keselamatan pasien di rumah sakit telah terbentuk dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa dimensi yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.

Dimensi Komunikasi tentang Kesalahan menunjukkan capaian tertinggi sebesar 98,01% (kategori tinggi). Hasil ini mencerminkan bahwa staf telah memiliki kesadaran dan keterbukaan yang sangat baik dalam mengkomunikasikan kesalahan yang terjadi, sebagai bagian dari upaya pembelajaran dan peningkatan keselamatan pasien.

Dimensi Keterbukaan Komunikasi memperoleh nilai 89,84% (kategori tinggi), yang menandakan bahwa tenaga kesehatan merasa cukup aman dan nyaman untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun kekhawatiran terkait keselamatan pasien tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif.

Pada dimensi Serah Terima dan Pertukaran Informasi, capaian sebesar 81,92% (kategori tinggi) menunjukkan bahwa proses handover antar petugas telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan standar komunikasi efektif untuk meminimalkan risiko kesalahan akibat informasi yang tidak lengkap.

Dimensi Dukungan Manajemen Rumah Sakit untuk Keselamatan Pasien memperoleh nilai 76,23% (kategori sedang). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen sudah terlihat, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam bentuk kebijakan, fasilitas pendukung, dan keterlibatan aktif pimpinan dalam program keselamatan pasien.

Dimensi Pembelajaran Organisasi dan Peningkatan Berkelanjutan menunjukkan capaian 91,35% (kategori tinggi). Hasil ini mencerminkan bahwa rumah sakit telah memiliki budaya belajar dari insiden dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pada dimensi Pelaporan Kejadian Keselamatan Pasien, capaian sebesar 72,11% (kategori

sedang) menunjukkan bahwa pelaporan kejadian telah berjalan namun belum optimal. Masih diperlukan upaya untuk mendorong pelaporan insiden secara konsisten, termasuk kejadian nyaris cedera (near miss).

Dimensi Respon terhadap Error memperoleh nilai 64,14% (kategori sedang). Hal ini menunjukkan bahwa respon organisasi terhadap kesalahan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menciptakan budaya non-punitif agar staf tidak merasa disalahkan ketika melaporkan kesalahan.

Dimensi Kepegawaian dan Kecepatan Kerja mendapatkan nilai 78,22% (kategori sedang). Capaian ini mengindikasikan bahwa beban kerja dan kecukupan staf masih menjadi tantangan yang dapat berdampak pada keselamatan pasien jika tidak dikelola dengan optimal.

Dimensi Dukungan Supervisor, Manajer, atau Pemimpin Klinis untuk Keselamatan Pasien memperoleh capaian 75,70% (kategori sedang). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan peran pimpinan unit dalam memberikan teladan, supervisi, dan dukungan nyata terhadap praktik keselamatan pasien di unit kerja.

Sementara itu, dimensi Kerjasama Tim menunjukkan capaian 90,44% (kategori tinggi), yang mencerminkan adanya kerja sama dan kolaborasi yang baik antar staf dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang tergolong tinggi . Komunikasi Tentang mengenai insiden di Lingkungan Rumah Sakit tergolong kuat, hal ini disebabkan oleh respon cepatnya pihak manajemen dalam menangani insiden keselamatan pasien dan juga memberikan umpan baik kepada unit serta memberi saran dan masukan terhadap unit agar kesalahan yang sama tidak berulang kembali.

Budaya lapor yang sedang ini diakibatkan kurangnya pemahaman petugas dalam melaporkan IKP, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelaporan insiden, ketakutan untuk melaporkan dan tingginya beban kerja.

5.2 Saran

Disarankan bagi manajemen rumah sakit mempertahankan, mengembangkan program-program keselamatan pasien yang telah berjalan dan memelihara budaya keselamatan pasien yang telah berjalan serta melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penerapan budaya keselamatan pasien secara menyeluruh dengan didukung oleh kebijakan dan mengaktualisasikan program keselamatan pasien yang terancang secara sistematis di semua instalasi atau bidang secara berkesinambungan agar berjalan efektif dan efisien. Saran-saran yang membangun dan dapat diterapkan dan dilaksanakan di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebaiknya segera dapat ditindaklanjuti.

Penyusun,
Ketua Komite PMKP



dr. Ari Putriani, Sp. PK

Malang, 13 Desember 2025
Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang,



dr. Resti Lestantini, M.Kes